

2026-06-27_tochter_an_kanzlei.emlemails/2026-06-27_tochter_an_kanzlei.eml

Von	"Dr. Maren Koerner" <maren.koerner@privatpost.de>
An	Kanzlei Ahlers und Brinkmann <kanzlei@privatpost.de>
Datum	Sat, 27 Jun 2026 18:42:00 +0200
Betreff	Unterlagen meines Vaters Heinz Körner

Sehr geehrter Herr Ahlers,

mein Vater hat gestern den Widerspruchsbescheid bekommen. Er war heute sehr aufgelöst, weil er nicht versteht, wie die Kasse sagen kann, dass ein Gehstock reicht.

Ich habe die Unterlagen angehängt beziehungsweise bringe sie am Montag mit:

- Bescheid vom 10.06.2026
- sein Widerspruch vom 20.06.2026
- Widerspruchsbescheid vom 24.06.2026
- Verordnung und Bericht der Ärzte
- Reha-Gutachten Falke
- Kostenvoranschlag Sanitätshaus

Wichtig: Er ist am 03.05. vor der Apotheke gefallen. Seitdem geht er fast gar nicht mehr allein raus. Ich arbeite im Klinikum im Schichtdienst und kann nicht jeden Weg übernehmen. Es geht ihm nicht um Luxus, sondern darum, selbst zum Arzt und zur Apotheke zu kommen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Maren Körner

Von	Insa Bülow <insa.buelow@ahlers-brinkmann.de>
An	Joost Ahlers <j.ahlers@ahlers-brinkmann.de>
Kopie	Mara Eilers <m.eilers@ahlers-brinkmann.de>
Datum	Sat, 18 Jul 2026 09:15:00 +0200
Betreff	26-06-KR-1187 / Klagefrist, Zeugin und Anlagenstand Körner

Guten Morgen Herr Ahlers,

ich habe den Widerspruchsbescheid vom 24. Juni, den Eingangsstempel des Mandanten vom 26. Juni und den Briefumschlag abgeglichen. Bei Monatsfrist und Wochenendverschiebung komme ich auf Montag, 27. Juli 2026. Im elektronischen Kalender stehen Vorfrist 20. Juli und Endfrist 27. Juli; bitte geben Sie die Fristberechnung heute noch frei.

Der Klageentwurf enthält derzeit die Anlagen K1 bis K11. K4, der vollständige MD-Bericht, liegt nur als unvollständiger Scan mit fehlender Seite 6 vor. K8, die Fahrprobe des Sanitätshauses, nennt noch keine Uhrzeit und keine lichte Aufzugbreite. Ich habe beides nachgefordert. Der Widerspruchsbescheid soll K1 bleiben, damit die Geschäftsstelle den angegriffenen Verwaltungsakt sofort findet.

Frau Anna Körner hat telefonisch erklärt, dass sie zu Stürzen, ausgefallenen Arztwegen und der Erprobung im Sanitätshaus aussagen kann. Sie ist nicht Ärztin; im bisherigen Entwurf steht versehentlich Frau Dr. Körner. Bitte korrigieren. Ihre ladungsfähige Anschrift und die genauen Wahrnehmungsthemen liegen im Zeugenblatt.

Soll parallel mit der Klage ein Eilantrag hinausgehen, brauche ich bis Montag 10:00 Uhr die endgültige Auswahl der eidesstattlichen Versicherungen und die Freigabe der getrennten Anlagenfolge E1 bis E9.

Viele Grüße

Insa Bülow
Rechtsanwaltsfachangestellte
Kanzlei Ahlers und Brinkmann
Achternstraße 27 · 26122 Oldenburg
Telefon 0441 21874-12

2026-09-18_gutachterin_uebersendung.emleml/2026-09-18_gutachterin_uebersendung.eml

Von	"Prof. Dr. Anneliese Wickenrath" <praxis@praxis-wickenrath.de>
An	Sozialgericht Oldenburg <poststelle@sg-oldenburg.de>
Kopie	Joost Ahlers <j.ahlers@ahlers-brinkmann.de>, NordCare Krankenkasse <prozess@nordcare.de>
Datum	Fri, 18 Sep 2026 14:02:00 +0200
Betreff	S 12 KR 188/26 / Gutachten Heinz Körner vom 16. September 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem Verfahren Körner gegen NordCare Krankenkasse übersende ich das aufgrund des Beweisbeschlusses vom 4. August 2026 erstellte Gutachten vom 16. September 2026 als PDF-Datei. Die Datei umfasst 38 Seiten einschließlich Literatur- und Anlagenverzeichnis; die Rechnung wird getrennt an die Justizkasse übermittelt.

Die persönliche Untersuchung fand am 2. September 2026 von 09:08 Uhr bis 11:46 Uhr in meiner barrierefrei zugänglichen Praxis statt. Anwesend waren Herr Körner, zeitweise seine Tochter Anna Körner und für die technische Erprobung Orthopädietechniker Sven Heuer. Verwendet wurden die im Gutachten bezeichneten Standard- und Elektrorollstühle. Messprotokolle, Fotografien der Anpassung und Einwilligungserklärungen sind als Anlagen G1 bis G6 beigelegt.

Herr Körner arbeitete kooperativ mit. Die Fahrproben wurden nach einer Einweisung durchgeführt; Pausen, Abbrüche und Hilfestellungen sind im Abschnitt 6 minutengenau dokumentiert. Eine rechtliche Bewertung oder Entscheidung über ein bestimmtes Fabrikat enthält das Gutachten nicht.

Bitte bestätigen Sie den lesbaren Eingang der Datei. Für schriftliche Ergänzungsfragen oder eine mündliche Erläuterung im Termin stehe ich nach gerichtlicher Anordnung zur Verfügung. Meine urlaubsbedingte Abwesenheit vom 5. bis 16. Oktober ist vorsorglich angezeigt.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Anneliese Wickenrath
Fachärztin für Neurologie und Rehabilitationsmedizin
Gerichtsstraße 14 · 26122 Oldenburg
Telefon 0441 77018-0

Vorgang	Datum	Zugang	Fristende	Status
Ausgangsbescheid	10.06.2026	12.06.2026	13.07.2026	Widerspruch am 20.06.2026 eingegangen
Widerspruchsbescheid	24.06.2026	26.06.2026	27.07.2026	Klagefrist offen
Mandatierung	29.06.2026	29.06.2026	03.07.2026	Klage und Eilantrag entscheiden
MD-Akte anfordern	29.06.2026		03.07.2026	offen
Facharzt-Ergänzung	29.06.2026		10.07.2026	offen

Hilfsmittel	Kosten	Selbstständige Nutzung	Nahbereich	Gegenargument
Unterarmgehstütze	45 EUR	nein	nein	Sturzgefahr und Sensibilitätsstörung
Rollator vorhanden	0 EUR	teilweise	nein	Bordsteine Schwellen Gehweg nicht sicher
Standard-Faltrollstuhl	740 EUR	nein	teilweise	Nutzung nur mit Begleitperson
Elektromobil	4200 EUR	unklar	teilweise	zu großer Wendekreis und Abstellproblem
Elektrollstuhl kompakt	10990 EUR	ja	ja	Fahrsicherheit durch Training absichern

sturzprotokoll_koerner.csv

csv/sturzprotokoll_koerner.csv

Datum	Ort	Hergang	Folge
14.02.2026	Badezimmer Wohnung	Ausrutschen beim Aufstehen von der Toilette	Prellung Hüfte links, kein Arztbesuch
02.04.2026	Küche Wohnung	Stolpern über Teppichkante	leichte Schürfwunde am Unterarm
03.05.2026	Gehweg vor Apotheke Peterstraße	Stolpern über abgesenkten Bordstein	Sturz mit Schürfwunden, Herbeirufen der Tochter
19.06.2026	Treppenhaus Wohnhaus	Ausrutschen auf der drittletzten Stufe	Abstützen mit Handlauf, kein Sturz bis zum Boden

verfahrenskalender_und_kostenvergleich.xlsx

xlsx/verfahrenskalender_und_kostenvergleich.xlsx

Tabellenblatt: Verfahrenskalender

Datum	Ereignis	Frist	Zuständig
12.05.2026	Antrag Elektrorollstuhl gestellt		Kläger
07.05.2026	Ärztliche Verordnung Dr. Stahlmann		Hausarzt
17.05.2026	Facharztbericht Dr. Radtke		Facharzt
20.05.2026	Kostenvoranschlag RehaTechnik Albrecht		Sanitätshaus
05.06.2026	MD-Stellungnahme Ablehnungsempfehlung		Medizinischer Dienst
10.06.2026	Ablehnungsbescheid		Kasse
18.06.2026	Privates Reha-Gutachten		RehaKompetenz Nordwest
20.06.2026	Widerspruch eingelegt	fristgerecht	Kläger
24.06.2026	Widerspruchsbescheid		Kasse
26.06.2026	Zustellung Widerspruchsbescheid	Klagefrist beginnt	Kläger
29.06.2026	Mandatierung Kanzlei Brammertz		Kläger
03.07.2026	Klageschrift gefertigt		Kanzlei
27.07.2026	Ende Klagefrist	letzter Tag	Kanzlei
22.07.2026	Klageerwiderung Kasse		Kasse
05.08.2026	Beweisbeschluss Sozialgericht		Sozialgericht Oldenburg
02.09.2026	Untersuchungstermin Sachverständige		Prof. Dr. Wickenrath
16.09.2026	Gutachten vorgelegt		Prof. Dr. Wickenrath
25.09.2026	Terminsverfügung		Sozialgericht Oldenburg
22.10.2026	Mündliche Verhandlung	10.30 Uhr, Saal 3	Sozialgericht Oldenburg

Tabellenblatt: Kostenvergleich

Hilfsmittel	Kosten in EUR	Förderfähig	Bemerkung
Unterarmgestütze	45	ja	bereits vorhanden
Rollator	0	ja	bereits vorhanden
Standard-Faltrollstuhl	740	ja	bereits vorhanden
Elektromobil	4200	strittig	Wendekreis und Abstellproblem im Altbau
Elektrorollstuhl Basis	8990	beantragt	Hauptangebot Kostenvoranschlag
Elektrorollstuhl mit Sitzlift	10990	beantragt Alternative	Zusatzausstattung
Elektrorollstuhl Standardmodell Kasse	6480	Gegenangebot Kasse	geringere Reichweite und Zuladung

Gehweg Peterstrasse Richtung Innenstadt

Aufnahme vom 24.05.2026.

Asphaltierter Gehweg, an zwei Stellen abgesenkte Bordsteine.

Leichtes Gefaelle auf den ersten 60 Metern, danach eben.

Wetterabhaengig teilweise nass und rutschig, keine Ueberdachung.

Fussgaengerampel an der Kreuzung Peterstrasse/Damm mit

Bordsteinabsenkung auf beiden Seiten.

Foto-Platzhalter, Bildbeschreibung fuer die Akte

Bilddatei: gehweg_peterstrasse.jpg

Hinterausgang mit Rollstuhlrampe

Aufnahme vom 24.05.2026.

Vom Vermieter 2019 nachtraeglich errichtete Holzrampe, Neigung etwa 9 Prozent.

Rampenlaenge 4,20 Meter, Breite 100 Zentimeter, beidseitig Handlauf.

Zugang zum Gehweg der Peterstrasse ueber die Rampe moeglich.

Von dort naechste Bushaltestelle 180 Meter, Apotheke 340 Meter,

Hausarztpraxis Dr. Stahlmann 460 Meter entfernt.

Foto-Platzhalter, Bildbeschreibung fuer die Akte

Bilddatei: hinterausgang_rampe.jpg

treppenhaus_altbau_eingang.jpg

jpg/treppenhaus_altbau_eingang.jpg

Treppenhaus Eingang, Peterstrasse 18

Aufnahme vom 24.05.2026, Wohnumfeldbegehung RehaTechnik Albrecht.

Schmales gewendertes Treppenhaus, keine Rampe, kein Aufzug.

Stufenhoehe circa 18 Zentimeter, insgesamt 16 Stufen zum ersten Obergeschoss.

Handlauf einseitig vorhanden, Breite des Treppenhauses 95 Zentimeter.

Ein Elektrorollstuhl kann diese Treppe nicht befahren, Nutzung nur innerhalb der Wohnung und nach Verlassen des Hauses ueber die vorhandene Rollstuhlrampe am Hinterausgang vorgesehen.

Foto-Platzhalter, Bildbeschreibung fuer die Akte

Bilddatei: treppenhaus_altbau_eingang.jpg

wohnzimmer_bewegungsflaeche.jpg

jpg/wohnzimmer_bewegungsflaeche.jpg

Wohnzimmer, Bewegungsflaeche

Aufnahme vom 24.05.2026.

Durchgangsbreite zwischen Sofa und Wohnzimmerschrank 88 Zentimeter.

Türbreite zum Flur 82 Zentimeter, ausreichend fuer Referenzmodell.

Teppichboden mit Kurzflor, laut Herstellerangabe befahrbar.

Kein Wendekreis von 1,50 Metern im Raum vorhanden, Rollstuhl
muss rueckwaerts aus dem Raum gefahren werden koennen.

Foto-Platzhalter, Bildbeschreibung fuer die Akte

Bilddatei: wohnzimmer_bewegungsflaeche.jpg

Hausarztpraxis Dr. med. Eva Stahlmann · Lange Straße 44 · 26122 Oldenburg

Facharztpraxis Dr. med. Malte Radtke
Nadorster Straße 91
26123 Oldenburg

Datum

8. Mai 2026

Aktenzeichen

Patient 77142 / Versicherter NK-184-772-01

Bearbeitung

Dr. med. Eva Stahlmann

Prüfung von Gehleistung, Sturzgefährdung und Hilfsmittelbedarf

Sehr geehrter Herr Kollege Radtke,

1. Diagnosen

Lumbale Spinalkanalstenose L3 bis L5; diabetische Polyneuropathie beider Füße; Zustand nach Hüfttotalendoprothese links 2022; Herzinsuffizienz NYHA II bis III; Schulterarthrose rechts; wiederholte Stürze.

2. Anlass

Herr Körner berichtet über zunehmende Gangunsicherheit und zwei aktuelle Stürze am 28. April im Hausflur sowie am 3. Mai vor der Apotheke. Der bisher genutzte Rollator und die Unterarmgehstütze ermöglichen nach meiner Beobachtung keine sichere selbstständige Mobilität außerhalb weniger Schritte in der Wohnung.

3. Fragestellung

Bitte beurteilen Sie Gehstrecke, Stand- und Wendestabilität, Armkraft für einen manuellen Rollstuhl, kardiale Belastbarkeit und die Eignung für einen kompakten Elektrorollstuhl. Benötigt wird eine funktionelle Aussage für Wohnung, Hauseingang und Nahbereich. Bitte berücksichtigen Sie Türbreiten und Schwellen aus dem beigefügten Wohnungsbogen.

4. Anlagen

Medikamentenplan vom 4. Mai 2026; Sturznotizen der Tochter; kardiologischer Bericht vom 19. April 2026; Wohnungsbogen mit Türmaßen.

Vielen Dank für die kollegiale Mitbeurteilung.

Dr. med. Eva Stahlmann

Fachärztin für Allgemeinmedizin

Datum

16. Mai 2026

Aktenzeichen

NK-184-772-01 / Hilfsmittel

Bearbeitung

Dr. med. Eva Stahlmann

Kompakter Elektrorollstuhl mit individueller Sitzanpassung

Sehr geehrte Damen und Herren,

1. Verordnung

Verordnet wird ein kompakter Elektrorollstuhl mit individueller Sitzanpassung, Kippschutz, Beleuchtung und Fahrtraining, geeignet für Innenräume, Hauseingang, Gehweg und tägliche Wege im Nahbereich. Die konkrete Modellauswahl soll nach Wohnungsprüfung und Erprobung erfolgen.

2. Funktionelle Begründung

Herr Körner kann kurze Schritte in der Wohnung nur unter erheblicher Sturzgefahr gehen. Unterarmgehstütze und Rollator gleichen Polyneuropathie, Gleichgewichtsstörung und rasche kardiale Erschöpfung nicht ausreichend aus. Ein manueller Rollstuhl kann wegen Schulterarthrose, eingeschränkter Handkraft und Belastungsdyspnoe nicht selbstständig angetrieben werden.

3. Untersuchung

Bei der Untersuchung am 16. Mai wurde die Gehstrecke mit Unterarmgehstütze nach 18 Metern abgebrochen. Der Puls stieg auf 118 pro Minute; es bestanden deutliche Dyspnoe und unsicherer Stand beim Wenden. Transfers vom Stuhl gelangen mit Armstütze. Aufmerksamkeit und Bedienverständnis waren unauffällig.

4. Versorgungsziel

Ziel ist die selbstständige Erschließung des Nahbereichs: Briefkasten, Hausarzt, Apotheke, Bäcker, Supermarkt, Friedhof und soziale Kontakte. Die Versorgung dient nicht einer bloßen Komfortsteigerung. Eine praktische Erprobung mit dokumentierter Fahrstrecke wird empfohlen.

Für medizinische Rückfragen stehe ich nach Entbindung von der Schweigepflicht zur Verfügung.

Dr. med. Eva Stahlmann

Fachärztin für Allgemeinmedizin

Facharztbericht Mobilität und Sturzrisiko

Praxis Dr. Malte Radtke, Facharzt für Orthopädie und Neurologie

Nadorster Straße 91, 26123 Oldenburg

Bericht vom 17.05.2026

Untersuchungsanlass

Vorstellung auf Überweisung der Hausärztin zur Beurteilung der Mobilität und Hilfsmittelversorgung. Herr Körner berichtet über zunehmende Unsicherheit beim Gehen, Angst vor dem Verlassen der Wohnung und wiederholte Stürze.

Klinischer Befund

Bereich	Befund
Gangbild	kleinschrittig, breitbasig, unsicher, deutliche Starthemmung
Stand	Romberg unsicher, Tandemstand nicht möglich
Gehstrecke mit Unterarmgehstütze	14 Meter im Flur, danach Abbruch wegen Schwindel und Dyspnoe
Gehstrecke mit Rollator	32 Meter auf ebener Strecke, nur unter Aufsicht, keine Bordsteinbewältigung
Treppe	nicht sicher, nur mit beidseitigem Geländer und Begleitung
Kraft	Hüftbeugung links 3 von 5, Fußheber beidseits 3 von 5
Sensibilität	herabgesetzt an beiden Füßen, Vibrationsempfinden deutlich vermindert
Schulter rechts	schmerzhaft eingeschränkte Abduktion, manueller Rollstuhlantrieb nicht realistisch
Kognition	orientiert, versteht Verkehrsregeln, keine relevante Aufmerksamkeitsstörung

Bewertung

Eine sichere Gehfähigkeit im sozialmedizinisch brauchbaren Sinne besteht nicht mehr. Herr Körner kann in der Wohnung einzelne Transfers und wenige Schritte durchführen. Für Wege außerhalb der Wohnung ist er praktisch nicht mehr selbständig mobil.

Ein Gehstock oder eine Unterarmgehstütze ist nicht ausreichend. Die Sturzgefahr entsteht gerade durch Gleichgewichtsstörung, Sensibilitätsausfall und fehlende Ausdauer. Ein Rollator hilft auf ebenem Praxisflur, nicht aber im tatsächlichen Wohnumfeld mit Schwellen, Haustür, Bordstein, Pflasterung und Verkehrsraum.

Ein manueller Rollstuhl scheidet als selbständige Lösung aus. Wegen Schulterbefund, Herzinsuffizienz und geringer Ausdauer wäre Herr Körner auf eine Begleitperson angewiesen. Der Behinderungsausgleich würde dann nicht durch das Hilfsmittel selbst, sondern durch fremde Hilfe erreicht.

Empfehlung

Aus fachärztlicher Sicht ist ein kompakter Elektrorollstuhl medizinisch erforderlich. Vor Bewilligung sollte ein Fahrtraining und eine Anpassung durch das Sanitätshaus erfolgen. Die Fahreignung erscheint bei langsamer Einstellung und Einweisung gegeben.

Beweiswert

Der Bericht beruht auf persönlicher Untersuchung, Gehprobe, neurologischem Befund und Auswertung der hausärztlichen Unterlagen. Eine reine Aktenprüfung ohne Gehprobe kann die tatsächliche Mobilität nur eingeschränkt beurteilen.

Eigenschilderung Alltag und Wege

Heinz Körner

aufgenommen am 21.05.2026 durch Tochter Maren Körner, vom Versicherten gegengelesen

Mein Morgen

Ich komme vom Bett bis zum Bad, wenn ich mich an der Kommode, am Türrahmen und am Waschbecken festhalte. Ich brauche dafür ungefähr zehn Minuten. Wenn ich schnell muss, geht es nicht. Ich habe im Flur einen Stuhl stehen, damit ich mich nach dem Bad setzen kann.

Den Rollator nutze ich in der Wohnung nicht gern, weil er an der Badezimmerschwelle hängen bleibt. Die Küche ist schmal. Wenn ich den Rollator wende, stoße ich an den Schrank. Mit dem Stock fühle ich mich nicht sicher. Der Stock hilft nur, wenn die Beine mitmachen.

Wege außer Haus

Ziel	Entfernung	Aktueller Zustand
Briefkasten im Erdgeschoss	etwa 35 Meter mit Treppe und Haustür	nur mit Pause und Festhalten am Geländer
Hausarzt	etwa 260 Meter	seit April nur noch mit Taxi oder Tochter
Apotheke	etwa 310 Meter	Sturz am 03.05.2026 vor der Rampe
Bäcker	etwa 420 Meter	seit Februar nicht mehr allein
Supermarkt	etwa 650 Meter	nur mit Tochter, ich sitze im Auto
Friedhof Gertrudenfriedhof	etwa 1.2 Kilometer	seit Weihnachten nicht mehr besucht

Warum ich den Elektrorollstuhl brauche

Ich möchte nicht sportlich fahren. Ich möchte zum Briefkasten, zum Arzt, zur Apotheke und manchmal zum Grab meiner Frau. Meine Tochter arbeitet im Klinikum. Sie kann nicht immer kommen. Ich rufe oft nicht an, weil ich ihr nicht zur Last fallen will.

Wenn ich mit dem Rollator draußen bin, schaue ich nur auf den Boden. Bei Bordsteinen weiß ich nicht, wie ich hinüberkommen soll. Ich bin einmal auf die rechte Seite gefallen und einmal nach hinten. Danach lag ich im Hausflur, bis der Nachbar kam.

Einen normalen Rollstuhl kann ich nicht selbst schieben. Ich habe es bei RehaTechnik Albrecht probiert. Nach wenigen Metern taten Schulter und Brust weh. Ich kam nicht geradeaus. Ich will nicht wieder abhängig davon sein, dass jemand mich schiebt.

Wohnung

Ich wohne seit 1979 in der Wohnung. Meine Frau ist dort gestorben. Ein Umzug ist für mich schwer vorstellbar. Der Vermieter hat gesagt, dass ein Treppenlift wegen des engen Treppenhauses und des Fluchtwegs nicht genehmigt wird. Ein Aufzug ist nicht vorhanden. Es gibt aber eine breite Abstellfläche im Erdgeschoss hinter der Haustür, dort könnte der Elektrorollstuhl stehen und geladen werden. Für die Wohnung selbst brauche ich ihn in Küche und Flur nur langsam, aber ich brauche ihn vor allem, um aus dem Haus und wieder zurückzukommen.

RehaTechnik Albrecht GmbH

Donnerschweer Straße 188, 26123 Oldenburg · Telefon 0441 73 60 18

Ortstermin: 18. Mai 2026 · Versicherter: Heinz Körner · Beraterin: Anja Voss

Wohnungsumfeld und Barrierefreiheitsprüfung

Betreff: Prüfung der Einsatzfähigkeit eines kompakten Elektrorollstuhls im Wohnumfeld Theaterwall 62, 26122 Oldenburg.

Der Ortstermin fand im Beisein von Herrn Körner und seiner Tochter Dr. Maren Körner statt. Die Messwerte beruhen auf unmittelbarer Aufnahme vor Ort; Fotos liegen der Handakte bei.

Gebäudezugang

Der Hauseingang hat zwei Stufen mit 14 und 16 Zentimetern Höhe. Im Hausflur beträgt die lichte Breite 108 Zentimeter. Der Aufzug beginnt erst im Hochparterre und ist für den Weg vom Bürgersteig zur Wohnung daher nicht allein ausreichend.

Wohnungsbereich

In der Wohnung sind Flur, Wohnzimmer und Küche mit einem kompakten Elektrorollstuhl erreichbar, wenn der Teppich im Flur entfernt und der Couchtisch versetzt wird. Die Badezimmertür ist mit 68 Zentimetern zu schmal; dort bleibt Hilfestellung erforderlich.

Praktische Konsequenz

Der Elektrorollstuhl ersetzt nicht jede bauliche Barriere. Er ermöglicht aber Wege im Erdgeschoss, zum Arzt, zur Apotheke und innerhalb der Wohnung deutlich sicherer als Rollator oder Gehstock. Die Versorgung ist deshalb nicht mit einem bloßen Gehstock vergleichbar.

Kostenvoranschlag und technische Versorgung

RehaTechnik Albrecht GmbH
Donnerschweer Straße 188, 26123 Oldenburg
Kostenvoranschlag vom 20.05.2026

Versicherter
Heinz Körner, geboren 14.03.1948
Versichertennummer: WEK-418-77-920
Vorgeschlagene Versorgung

Position	Beschreibung	Betrag
Elektorollstuhl Permobil M1 Compact	Innen- und Nahbereichsversorgung, reduzierte Geschwindigkeit, kompakter Wendekreis	7.980,00 EUR
Sitzanpassung	druckentlastendes Sitzkissen, Beckengurt, seitliche Führung	1.240,00 EUR
Bedienmodul rechts	fein justierbarer Joystick, Handauflage	420,00 EUR
Beleuchtung und Reflektoren	Nahbereich und Straßenquerung	310,00 EUR
Bordsteinassistent klein	Kippstabilität bei niedrigen Kanten	390,00 EUR
Einweisung und Fahrtraining	zwei Termine vor Ort, Tochter anwesend	360,00 EUR
Wartungspauschale erstes Jahr	sicherheitsrelevante Kontrolle	290,00 EUR
Gesamt brutto	einschließlich Lieferung	10.990,00 EUR

Technische Begründung

Ein Standard-Faltrollstuhl ist im Fall Körner nicht geeignet, weil der Versicherte ihn nicht selbst antreiben kann. Ein Elektrorollstuhl mit großer Außenbereichsausführung ist technisch nicht erforderlich und im Gebäude schwer handhabbar. Das vorgeschlagene Modell ist bewusst kompakt gewählt. Die Versorgung ist darauf ausgelegt, im Erdgeschoss abgestellt und geladen zu werden. Für die zwei Eingangsstufen ist eine mobile Kurzrampe gesondert möglich. Das Hilfsmittel ersetzt keinen Treppenlift und keine Wohnraumanpassung.

Fahrprobe

Am 18.05.2026 wurde im Innenhof eine langsame Fahrprobe durchgeführt. Herr Körner konnte nach 25 Minuten Einweisung:

1. geradeaus fahren,
2. in Schrittgeschwindigkeit wenden,
3. anhalten,
4. eine Türschwelle mit Begleitung überwinden,
5. den Joystick rechts sicher bedienen.

Kritisch bleibt das Rückwärtsfahren. Es wird empfohlen, den Rollstuhl zunächst auf niedrige Höchstgeschwindigkeit zu begrenzen und nach drei Wochen eine Nachschulung durchzuführen.

Stellungnahme des Medizinischen Dienstes

MD Niedersachsen

Beratungszentrum Oldenburg

Gutachterliche Stellungnahme nach Aktenlage vom 05.06.2026

Auftrag

Prüfung der medizinischen Notwendigkeit eines Elektrorollstuhls nach Paragraf 33 SGB V.

Vorliegende Unterlagen

Unterlage	Datum	Bewertung des MD
Hausärztliche Verordnung	16.05.2026	berücksichtigt
Facharztbericht Dr. Radtke	17.05.2026	berücksichtigt
Kostenvoranschlag RehaTechnik Albrecht	20.05.2026	berücksichtigt
Eigenschilderung Versicherter	21.05.2026	nur eingeschränkt verwertbar
Wohnumfeldnotiz Sanitätshaus	18.05.2026	technisch, nicht medizinisch

Eine persönliche Untersuchung fand nicht statt.

Zusammenfassung der MD-Bewertung

Der Versicherte ist in seiner Gehfähigkeit eingeschränkt. Eine vollständige Gehunfähigkeit ist aus den Unterlagen nicht ableitbar. Er kann nach fachärztlichem Bericht im Innenbereich wenige Meter gehen und mit Rollator auf ebener Strecke 32 Meter zurücklegen. Damit ist eine Restmobilität vorhanden.

Die Versorgung mit einem Elektrorollstuhl ist nach Aktenlage nicht erforderlich. Vorrangig seien auszuschöpfen:

1. konsequente Nutzung einer Unterarmgehstütze,
2. Training mit vorhandenem Rollator,
3. Standard-Faltrollstuhl für längere Wege mit Begleitperson,
4. Prüfung wohnumfeldverbessernder Maßnahmen über Pflegekasse oder Vermieter.

Wirtschaftliche Bewertung

Der beantragte Elektrorollstuhl verursacht Kosten von 10.990,00 EUR. Ein Standard-Faltrollstuhl aus dem Vertragssortiment der Kasse liegt bei etwa 740,00 EUR. Ein Rollator ist bereits vorhanden. Ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich ist daher die einfache Versorgung.

Schlussfolgerung

Aus sozialmedizinischer Sicht wird empfohlen, den Antrag abzulehnen. Eine erneute Prüfung kann erfolgen, wenn:

5. eine aktuelle fachärztliche Bescheinigung eine vollständige Unfähigkeit zur Nutzung einfacherer Hilfsmittel belegt,
6. ein Fahrtraining eine sichere Bedienung des Elektrorollstuhls nachweist,
7. die Abstell- und Ladesituation brandschutzrechtlich geklärt ist.

Interne Schwäche der Stellungnahme

Diese Passage ist aus der Akte der Krankenkasse entnommen: Die Stellungnahme beruht nur auf Aktenlage. Gehprobe, Wohnumfeld, Rollstuhltest und tatsächliche Nutzung einfacher Hilfsmittel wurden nicht selbst überprüft.

Ablehnungsbescheid der Krankenkasse

Weser-Ems Gesundheitskasse

Leistungszentrum Hilfsmittel

Stau 35, 26122 Oldenburg

Oldenburg, 10.06.2026

Versicherter: Heinz Körner

Versichertennummer: WEK-418-77-920

Aktenzeichen: HM-2026-7714-E

Bescheid

Sehr geehrter Herr Körner,

Ihren Antrag auf Versorgung mit einem Elektrorollstuhl vom 22.05.2026 lehnen wir ab.

Begründung

Nach Paragraph 33 SGB V haben Versicherte Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln, wenn diese im Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine Behinderung auszugleichen. Die Leistung muss außerdem ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie darf das Maß des Notwendigen nicht überschreiten.

Der Medizinische Dienst hat die Unterlagen geprüft. Danach ist Ihre Gehfähigkeit eingeschränkt, aber nicht aufgehoben. Sie können kurze Strecken in der Wohnung und auf ebener Strecke mit Rollator zurücklegen. Eine Versorgung mit Unterarmgehstütze, Rollator und bei längeren Wegen mit Standard-Faltrollstuhl ist ausreichend.

Der beantragte Elektrorollstuhl kostet nach Kostenvoranschlag 10.990,00 EUR. Diese Versorgung ist im Verhältnis zu den vorhandenen einfacheren Hilfsmitteln nicht wirtschaftlich. Bauliche Erschwernisse Ihrer Wohnung und Ihres Hauseingangs können nicht durch eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeglichen werden. Für Wohnumfeldmaßnahmen wenden Sie sich bitte an Ihre Pflegekasse oder Ihren Vermieter.

Entscheidung

Wir übernehmen die Kosten für den beantragten Elektrorollstuhl nicht.

Wir bieten Ihnen an, über unser Vertragssanitätshaus einen Standard-Faltrollstuhl prüfen zu lassen. Bei Bedarf kann zusätzlich eine physiotherapeutische Gangschulung mit Ihrem behandelnden Arzt besprochen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Weser-Ems Gesundheitskasse einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Weser-Ems Gesundheitskasse

Leistungszentrum Hilfsmittel

Privates Reha-Gutachten

Reha-Kompetenz Nordwest

Diplom-Rehabilitationspädagoge und Hilfsmittelberater Sven Falke

Oldenburg, 18.06.2026

Auftrag

Heinz Körner bat um Prüfung, ob die beantragte Versorgung mit einem kompakten Elektrorollstuhl medizinisch-funktionell nachvollziehbar ist. Die Untersuchung fand am 17.06.2026 in Wohnung, Treppenhaus, Innenhof und Gehwegbereich statt. Anwesend waren Herr Körner und seine Tochter.

Methodik

- 1. Sichtung der ärztlichen Unterlagen.
- 2. Beobachtung Transfers Bett, Stuhl, Wohnungstür.
- 3. Gehprobe mit Unterarmgehstütze.
- 4. Gehprobe mit Rollator im Hausflur und auf Gehweg.
- 5. Test manueller Faltrollstuhl.
- 6. Test kompakter Elektrorollstuhl in Innenhof und Gehwegbereich.

Ergebnisse

Prüfung	Ergebnis
Unterarmgehstütze	nach 9 Metern unsicherer Stand, Abbruch wegen Schwanken
Rollator im Hausflur	19 Meter möglich, Wendung unsicher, Türschwelle kritisch
Rollator außen	nach Bordsteinversuch Abbruch, deutliche Sturzangst
Standard-Faltrollstuhl	Versicherter kann ihn nicht geradeaus selbst antreiben
Elektrorollstuhl	sichere Geradeausfahrt, kontrolliertes Bremsen, langsames Wenden möglich
Kognition und Reaktion	ausreichendes Verständnis, Bremsreaktion in Schrittgeschwindigkeit vorhanden

Fachliche Bewertung

Ein Hilfsmittel ist nur dann geeignet, wenn es im konkreten Lebensumfeld nutzbar ist. Gehstock und Rollator sind für Herrn Körner keine tragfähige Nahbereichsversorgung. Sie setzen eine Reststabilität voraus, die im Alltag nicht vorhanden ist. Der Standard-Faltrollstuhl verschiebt die Mobilität auf eine Begleitperson; er stellt keine selbständige Mobilität her.

Der Elektrorollstuhl ist nicht bloß komfortabler. Er ist das erste Hilfsmittel in der Kette, das den Weg ab Hauseingang in den Nahbereich praktisch ermöglicht. Die Versorgung sollte langsam eingestellt, mit Kippschutz und Fahrtraining versehen und nach vier Wochen kontrolliert werden.

Abgrenzung Wirtschaftlichkeit

Das günstigere Hilfsmittel ist nicht wirtschaftlich, wenn es den Versorgungszweck nicht erfüllt. Eine Versorgung mit einem 740,00-EUR-Faltrollstuhl wäre nur scheinbar günstiger, weil Herr Körner damit ohne fremde Hilfe weiterhin nicht zum Arzt, zur Apotheke oder zum Briefkasten kommt.

Schlussfolgerung

Die Versorgung mit einem kompakten Elektrorollstuhl ist aus reha-fachlicher Sicht erforderlich und angemessen. Hilfsweise muss die Krankenkasse eine gleich geeignete elektrische Mobilitätslösung anbieten; ein Gehstock, Rollator oder Standard-Faltrollstuhl genügt nicht.

Heinz Körner

Theaterwall 62, 26122 Oldenburg · Versichertennummer WEK-418-77-920

Oldenburg, 17. Juni 2026 · eigenhändig vorbereiteter Widerspruch

Widerspruch gegen die Ablehnung des Elektrorollstuhls

An die Weser-Ems Gesundheitskasse, Leistungszentrum Hilfsmittel, Stau 35, 26122 Oldenburg.

Betreff: Bescheid vom 10. Juni 2026, Aktenzeichen HM-2026-7714-E.

Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit lege ich Widerspruch gegen Ihren Bescheid ein. Ich kann Ihre Entscheidung nicht verstehen, weil ich mit dem Gehstock nicht mehr sicher aus der Wohnung komme und in den letzten Monaten mehrfach beinahe gestürzt bin.

Ich benutze den Gehstock nur noch innerhalb sehr kurzer Strecken. Schon der Weg zur Apotheke am Julius-Mosen-Platz ist für mich ohne Hilfe kaum möglich. Meine Tochter kann mich nicht täglich begleiten. Ich möchte weiter selbst zum Arzt, zur Apotheke und zum Einkaufen kommen, ohne jedes Mal einen Krankentransport oder Nachbarn bitten zu müssen.

Der Facharztbericht von Dr. Radtke und das Gutachten von Reha-Kompetenz Nordwest beschreiben aus meiner Sicht richtig, dass Rollator und Gehstock nicht ausreichen. Bitte prüfen Sie die Unterlagen noch einmal und schicken Sie mir eine verständliche Begründung, falls Sie trotzdem ablehnen.

Mit freundlichen Grüßen Heinz Körner

Widerspruchsbescheid der Krankenkasse

Weser-Ems Gesundheitskasse

Widerspruchsstelle

Stau 35, 26122 Oldenburg

Oldenburg, 24.06.2026

Versicherter: Heinz Körner

Versichertennummer: WEK-418-77-920

Aktenzeichen: HM-2026-7714-E-W

Entscheidung

Der Widerspruch gegen den Bescheid vom 10.06.2026 wird zurückgewiesen.

Gründe

Der Ausgangsbescheid ist rechtmäßig. Ein Anspruch auf Versorgung mit dem beantragten Elektrorollstuhl besteht nicht.

Die Widerspruchsstelle hat die ärztlichen Unterlagen, die Stellungnahme des Medizinischen Dienstes und das von Ihnen vorgelegte private Reha-Gutachten geprüft. Danach bestehen Einschränkungen der Mobilität. Eine vollständige Gehunfähigkeit ist jedoch nicht belegt. Der Versicherte kann nach den Unterlagen kurze Strecken gehen. Für längere Wege kommt ein Standard-Faltrollstuhl in Betracht.

Das private Reha-Gutachten führt zu keiner anderen Bewertung. Es wurde im Auftrag des Versicherten eingeholt und ersetzt keine sozialmedizinische Begutachtung durch den Medizinischen Dienst. Zudem bestätigt auch dieses Gutachten, dass Transfers und einzelne Gehstrecken möglich sind.

Die beantragte Versorgung überschreitet das Maß des Notwendigen. Der Elektrorollstuhl ist mit Kosten von 10.990,00 EUR erheblich teurer als die einfache Versorgung. Nach Paragraph 12 SGB V müssen Leistungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein.

Soweit Sie auf bauliche Hindernisse im Treppenhaus, den Hauseingang und die fehlende Barrierefreiheit verweisen, ist hierfür nicht die gesetzliche Krankenversicherung zuständig. Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds können gegebenenfalls bei der Pflegekasse beantragt werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Widerspruchsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim Sozialgericht Oldenburg erhoben werden. Die Klage kann schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder nach Maßgabe der zugelassenen elektronischen Übermittlungswege erhoben werden.

Der Widerspruchsbescheid wurde am 26.06.2026 zugestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Weser-Ems Gesundheitskasse

Widerspruchsstelle

Entwurf Klageschrift

Kanzlei Ahlers und Brinkmann, Fachanwälte für Sozialrecht

Gottorpstraße 29, 26122 Oldenburg

Telefon 0441 92 37 60-0

Rechtsanwalt Joost Ahlers

Unser Zeichen: 26-06-KR-1187

Nicht eingereicht. Stand 29.06.2026. Versand per beA nach Mandantenfreigabe.

An das Sozialgericht Oldenburg

Schloßplatz 10

26122 Oldenburg

Klage

des Herrn Heinz Körner, Theaterwall 62, 26122 Oldenburg,

Kläger,

gegen

die Weser-Ems Gesundheitskasse, Stau 35, 26122 Oldenburg,

Beklagte.

Anträge

1. Der Bescheid der Beklagten vom 10.06.2026 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 24.06.2026 wird aufgehoben.
2. Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger mit einem geeigneten kompakten Elektrorollstuhl für Innenräume, Hausausgang und Nahbereich zu versorgen, hilfsweise über den Antrag unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu entscheiden.
3. Die Beklagte trägt die notwendigen außergerichtlichen Kosten des Klägers.

Sachverhalt

Der 78-jährige Kläger ist gesetzlich krankenversichert. Er leidet unter lumbaler Spinalkanalstenose, diabetischer Polyneuropathie, Zustand nach Hüft-TEP links, Herzinsuffizienz und wiederholten Stürzen. Er lebt allein in einem Altbau in Oldenburg. Sein täglicher Nahbereich umfasst Briefkasten, Hausarzt, Apotheke, Bäcker, Supermarkt und den Besuch des Grabes seiner Ehefrau.

Mit Verordnung vom 16.05.2026 beantragte der Kläger die Versorgung mit einem kompakten Elektrorollstuhl. Der Kostenvoranschlag der RehaTechnik Albrecht GmbH vom 20.05.2026 beträgt 10.990,00 EUR. Die Beklagte lehnte den Antrag mit Bescheid vom 10.06.2026 ab und stützte sich auf eine reine Aktenstellungnahme des Medizinischen Dienstes vom 05.06.2026. Den Widerspruch des Klägers vom 20.06.2026 wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 24.06.2026 zurück.

Rechtliche Würdigung

Der Kläger hat Anspruch auf Hilfsmittelversorgung nach Paragraph 33 SGB V. Das beantragte Hilfsmittel dient dem Behinderungsausgleich. Entscheidend ist nicht, ob der Kläger noch einzelne Schritte in der Wohnung leisten kann. Entscheidend ist, ob die angebotene Versorgung den konkreten Mobilitätsbedarf im Basisausgleich praktisch deckt.

Gehstock, Unterarmgehstütze und Rollator sind nach den vorliegenden Befunden nicht ausreichend. Sie setzen eine sichere Restgehfähigkeit voraus, die beim Kläger gerade fehlt. Ein Standard-Faltrollstuhl ist ebenfalls ungeeignet, weil der Kläger ihn wegen Schulterbeschwerden, Herzinsuffizienz und geringer

Ausdauer nicht selbständig antreiben kann. Eine Versorgung, die nur mit schiebender Begleitperson funktioniert, stellt keine selbständige Mobilität her.

Das Wirtschaftlichkeitsgebot nach Paragraf 12 SGB V rechtfertigt die Ablehnung nicht. Wirtschaftlich ist nicht das billigste Hilfsmittel, sondern das ausreichende und zweckmäßige Hilfsmittel. Ein günstiger Rollstuhl, der den Versorgungszweck verfehlt, ist nicht wirtschaftlich.

Die Beklagte hat die konkrete Bedarfslage unzureichend ermittelt. Der Medizinische Dienst hat den Kläger nicht persönlich untersucht, keine Gehprobe durchgeführt, das Wohnumfeld nicht gesehen und den Test des manuellen Rollstuhls nicht nachvollzogen. Dem stehen der fachärztliche Bericht, die hausärztliche Verordnung und das private Reha-Gutachten mit persönlicher Untersuchung gegenüber.

Beweisangebote

4. Bericht Dr. Radtke vom 17.05.2026.
5. Verordnung Dr. Stahlmann vom 16.05.2026.
6. Gutachten Reha-Kompetenz Nordwest vom 18.06.2026.
7. Zeugin Dr. Maren Körner zu Stürzen, Alltagswegen und fehlender Begleitmöglichkeit.
8. Sachverständigengutachten aus Neurologie, Orthopädie und Reha-Technik.
9. Augenschein der Wohn- und Hausausgangssituation, hilfsweise Fotodokumentation und Wohnumfeldbericht.

Eilrechtsschutz

Gesondert ist ein Antrag nach Paragraf 86b SGG zu prüfen. Der Kläger ist ohne geeignete Versorgung aktuell faktisch an die Wohnung gebunden. Es bestehen Sturzgefahr, fehlende sichere Arzt- und Apothekenwege und eine zunehmende Vereinsamung. Die Hauptsache kann nicht ohne erhebliche Nachteile abgewartet werden.

Entwurf Klageerwiderung der Krankenkasse

Weser-Ems Gesundheitskasse

Justitiariat und Prozessabteilung

Stau 35, 26122 Oldenburg

Aktenzeichen: HM-2026-7714-E-K

Nicht eingereicht. Interner Entwurf der Prozessabteilung vom 08.07.2026.

An das Sozialgericht Oldenburg

In dem Rechtsstreit Heinz Körner gegen Weser-Ems Gesundheitskasse

Antrag

Die Klage wird abgewiesen.

Begründung

Die angefochtenen Bescheide sind rechtmäßig. Der Kläger hat keinen Anspruch auf die begehrte Versorgung mit dem konkret beantragten Elektrorollstuhl.

Keine vollständige Gehunfähigkeit

Aus den Unterlagen folgt keine vollständige Aufhebung der Gehfähigkeit. Der Kläger kann nach dem Facharztbericht in der Wohnung einzelne Wege bewältigen und mit Rollator auf ebener Strecke 32 Meter zurücklegen. Damit liegt keine Situation vor, in der ausschließlich ein Elektrorollstuhl den Basisausgleich leisten kann.

Vorrang einfacher Hilfsmittel

Die Beklagte hat nicht jede Mobilitätsunterstützung abgelehnt. Angeboten wurde die Prüfung eines Standard-Faltrollstuhls. Zudem sind Gehstütze, Rollator, physiotherapeutisches Training und gegebenenfalls wohnumfeldverbessernde Maßnahmen vorrangig zu prüfen. Die gesetzliche Krankenversicherung schuldet keine optimale Versorgung und keine vollständige Kompensation baulicher Hindernisse.

Wirtschaftlichkeit

Der beantragte Elektrorollstuhl kostet 10.990,00 EUR. Ein Standard-Faltrollstuhl aus dem Vertragssortiment ist erheblich günstiger. Der Kläger begehrt eine Versorgung, die auch durch bauliche und soziale Umstände veranlasst ist. Diese Umstände liegen nicht allein im Verantwortungsbereich der Krankenversicherung.

Privates Gutachten

Das private Reha-Gutachten ist nicht neutral. Es wurde vom Kläger beauftragt und ersetzt keine Begutachtung durch den Medizinischen Dienst. Außerdem bestätigt es, dass der Kläger Transfers durchführen und einzelne Strecken gehen kann. Es belegt daher nicht, dass nur ein Elektrorollstuhl in Betracht kommt.

Fahrsicherheit

Die sichere Bedienung des Elektrorollstuhls ist nicht ausreichend geklärt. Der Kläger ist 78 Jahre alt, sturzgefährdet und herzinsuffizient. Das Rückwärtsfahren wurde im privaten Gutachten als kritisch beschrieben. Bevor eine derart kostenintensive Versorgung bewilligt wird, müsste die Fahrsicherheit belastbar festgestellt werden.

Hilfsweise

Falls das Gericht weiteren Ermittlungsbedarf sieht, wird angeregt, ein unabhängiges Sachverständigengutachten einzuholen und den Medizinischen Dienst um eine persönliche Untersuchung zu ersuchen. Eine Verurteilung unmittelbar zur Versorgung mit dem konkret benannten Modell ist nicht angezeigt.

Gerichtlicher Hinweis und Beweisfragen

Sozialgericht Oldenburg

Kammer für Krankenversicherungssachen

Entwurf richterlicher Hinweis vom 22.07.2026

Vorläufige Einschätzung

Die Kammer weist darauf hin, dass die Sache nicht allein nach der Frage entschieden werden kann, ob der Kläger noch einzelne Schritte zurücklegen kann. Für Paragraf 33 SGB V ist maßgeblich, welches Hilfsmittel im konkreten Einzelfall den Behinderungsausgleich tatsächlich leistet.

Der bisherige Aktenstand enthält Widersprüche:

1. Der Medizinische Dienst sieht Gehstütze, Rollator und Standard-Faltrollstuhl als ausreichend an.
2. Facharzt und privates Reha-Gutachten halten genau diese Hilfsmittel praktisch für ungeeignet.
3. Die Krankenkasse stellt stark auf Kosten ab.
4. Die Klägerseite stellt stark auf Selbständigkeit, Sturzgefahr und Nahbereich ab.

Beweisfragen an einen Sachverständigen

5. Welche objektive Gehfähigkeit besteht bei Heinz Körner innerhalb der Wohnung, im Treppenhaus und im Nahbereich?
6. Kann der Kläger eine Unterarmgehstütze sicher nutzen?
7. Kann der Kläger einen Rollator im tatsächlichen Wohnumfeld sicher nutzen?
8. Kann der Kläger einen Standard-Faltrollstuhl eigenständig und dauerhaft genug antreiben?
9. Ist ein Elektrorollstuhl medizinisch-funktionell erforderlich, um den Basisausgleich der Mobilität im Nahbereich herzustellen?
10. Ist die Bedienung eines Elektrorollstuhls bei langsamer Einstellung und Fahrtraining hinreichend sicher?
11. Gibt es ein gleich geeignetes, wirtschaftlicheres Hilfsmittel?

Hinweise an die Beteiligten

Die Beklagte möge mitteilen, ob sie eine persönliche Begutachtung durch den Medizinischen Dienst veranlasst. Eine reine Aktenlage kann bei streitiger tatsächlicher Mobilität unzureichend sein.

Der Kläger möge eine aktuelle Fotodokumentation von Hauseingang, Abstellfläche, Gehweg und den typischen Nahbereichswegen vorlegen. Außerdem ist darzulegen, ob ein Eilantrag gestellt wird oder ob die Hauptsache vorrangig betrieben werden soll.

Vergleichsfenster

Ein Vergleich könnte lauten:

Die Beklagte bewilligt ohne Anerkennung einer Rechtspflicht eine geeignete elektrische Mobilitätsversorgung im Nahbereich nach erneuter technischer Erprobung. Der Kläger nimmt am Fahrtraining teil. Die endgültige Modellauswahl erfolgt durch Vertragssanitätshaus und behandelnden Facharzt. Die Kosten des Widerspruchsverfahrens werden zur Hälfte übernommen.

Terminsverfügung und Hinweise zur mündlichen Verhandlung

Sozialgericht Oldenburg

Kammer für Krankenversicherungssachen

Klingenbergstraße 4, 26133 Oldenburg

Aktenzeichen: S 12 KR 188/26

Oldenburg, den 25.09.2026

In dem Rechtsstreit Körner gegen Weser-Ems Gesundheitskasse wird Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt auf:

Donnerstag, den 22.10.2026, 10.30 Uhr, Sitzungssaal 3.

Hinweise der Kammer

Das eingeholte Sachverständigengutachten vom 16.09.2026 liegt den Beteiligten vor. Die Kammer weist darauf hin, dass sich die Entscheidung maßgeblich auf die dort getroffenen Feststellungen zur Gehstrecke mit Rollator, zur Belastbarkeit beim manuellen Rollstuhlantrieb und zum Ergebnis des Fahrversuchs mit dem Elektrorollstuhl stützen wird.

Die Beteiligten erhalten Gelegenheit, bis zum Termin ergänzend vorzutragen, insbesondere zu der Frage, ob und in welchem Umfang die im Gutachten beschriebene Erschöpfung bei Nutzung des manuellen Rollstuhls eine dauerhafte, alltagstaugliche Versorgung ausschließt.

Ein Vergleichsvorschlag wurde bislang von keiner Seite unterbreitet. Die Kammer regt an, vor dem Termin zu prüfen, ob eine gütliche Einigung, etwa durch eine testweise Versorgung mit Rückgaberecht, in Betracht kommt.

Ladung der Beteiligten

Geladen werden der Kläger persönlich sowie ein Vertreter der Beklagten mit Entscheidungsbefugnis. Der Sachverständigen wird anheimgestellt, an der Verhandlung teilzunehmen, falls Rückfragen zum Gutachten zu erwarten sind.

Fristenblatt und Anlagenverzeichnis

Fristenblatt

Frist	Berechnung	Ergebnis
Widerspruch gegen Ausgangsbescheid	Bescheid 10.06.2026, Widerspruch 20.06.2026	fristgerecht
Klage gegen Widerspruchsbescheid	Zugang 26.06.2026, Monatsfrist	Ende Montag, 27.07.2026
Kanzlei-Wiedervorlage	sofort nach Mandatierung	03.07.2026
MD-Akte anfordern	Akteneinsicht Verwaltungsvorgang	sofort
Facharzt-Ergänzung	kurze Stellungnahme zu Hilfsmittelalternativen	bis 10.07.2026
Beweisbeschluss Rückfragen	Frist laut gerichtlichem Hinweis	zwei Wochen ab Zustellung
Terminsvorbereitung	vor mündlicher Verhandlung	bis 15.10.2026

Anlagenverzeichnis Klägerseite

Anlage	Dokument
K 1	Bescheid Weser-Ems Gesundheitskasse vom 10.06.2026
K 2	Widerspruch Heinz Körner vom 20.06.2026
K 3	Widerspruchsbescheid vom 24.06.2026
K 4	Überweisung und Hilfsmittelverordnung Dr. Stahlmann
K 5	Facharztbericht Dr. Radtke vom 17.05.2026
K 6	Eigenschilderung Alltag und Wege
K 7	Wohnumfeldbericht RehaTechnik Albrecht
K 8	Kostenvoranschlag RehaTechnik Albrecht vom 20.05.2026
K 9	MD-Stellungnahme vom 05.06.2026
K 10	Privates Reha-Gutachten vom 18.06.2026
K 11	E-Mail Tochter vom 27.06.2026
K 12	Gerichtliches Sachverständigengutachten vom 16.09.2026

Offene Arbeitspunkte

Vor dem Verhandlungstermin sind noch die ergänzende Stellungnahme des Facharztes zur Belastbarkeit beim manuellen Rollstuhlantrieb einzuholen und die Reisekosten des Sachverständigen abzurechnen. Die Kanzlei prüft zudem, ob eine testweise Versorgung mit Rückgaberecht als Vergleichsgrundlage angeboten werden kann.

Ärztliche Verordnung, vollständig ausformuliert

Hausarztpraxis Dr. Ferdinand Stahlmann

Donnerschweer Straße 44, 26123 Oldenburg

Verordnung vom 16.05.2026 für Herrn Heinz Körner, geboren 03.02.1948, wohnhaft Donnerschweer Straße 112, 26123 Oldenburg.

1. Diagnosen nach ICD-10

ICD-10	Diagnose
M48.06	Spinalkanalstenose, Lumbalbereich
G63.2	Diabetische Polyneuropathie
Z96.641	Zustand nach Hüft-Totalendoprothese links
R26.81	Gangunsicherheit
E11.90	Diabetes mellitus Typ 2 ohne Komplikationen, entgleist mit Folgeschäden anderenorts kodiert

2. Verordnete Hilfsmittelversorgung

Verordnet wird ein Elektrorollstuhl, kompakte Innenraum- und Nahbereichsausführung, mit Kippschutz, gedrosselter Geschwindigkeit und Fahrtraining. Hilfsmittelnummer nach Produktgruppe 18 des Hilfsmittelverzeichnisses.

3. Begründung des Mobilitätsverlusts

Herr Körner kann im Innenbereich nur wenige Schritte mit Unterarmgehstütze zurücklegen, danach droht Sturzgefahr durch die diabetische Polyneuropathie mit vermindertem Gefühl in beiden Füßen. Der Rollator bietet auf ebener Strecke im Hausflur begrenzte Sicherheit, ist aber auf dem unebenen Gehweg vor dem Haus und beim Überqueren der Bordsteinkante nicht ausreichend sicher nutzbar. Ein manueller Rollstuhl kann von Herrn Körner wegen eingeschränkter Schulterkraft nach der Hüftoperation nicht selbstständig angetrieben werden.

4. Behandlungsziel

Ziel der Versorgung ist die Wiederherstellung einer selbstständigen Mobilität im Nahbereich der Wohnung, insbesondere für Arztbesuche, Apothekenwege und den Weg zum Briefkasten, ohne durchgehende Angewiesenheit auf eine Begleitperson.

5. Dringlichkeit

Angeichts wiederholter Stürze in den letzten zwölf Monaten und der zunehmenden sozialen Isolation wird eine zeitnahe Bearbeitung des Antrags dringend angeraten.

Detaillierter Facharztbericht Neurologie

Neurologische Praxis am Pferdemarkt

Dr. Elisabeth Radtke, Fachärztin für Neurologie

Pferdemarkt 12, 26121 Oldenburg

1. Untersuchungsdaten

Untersuchung am 17.05.2026 durch Dr. Elisabeth Radtke, Fachärztin für Neurologie, im Rahmen der Abklärung der Gangstörung und Sturzneigung.

2. Neurologischer Befund

Deutlich reduzierte Vibrationsempfindung beidseits distal betont, abgeschwächte Achillessehnenreflexe beidseits, positiver Romberg-Test mit Fallneigung nach hinten. Gangbild kleinschrittig, breitbasig, mit deutlich verlängerter Standphase.

3. Elektrophysiologische Zusatzdiagnostik

Nervenleitgeschwindigkeitsmessung bestätigt eine sensomotorische Polyneuropathie beider Beine, vereinbar mit der bekannten diabetischen Genese. Die Befunde erklären die verminderte Standfestigkeit und die erhöhte Sturzgefahr insbesondere auf unebenem Untergrund.

4. Funktionelle Einschätzung

Die Gehstrecke ohne Hilfsmittel liegt unter 10 Metern, mit Unterarmgehstütze bei kontrollierten Bedingungen bei etwa 15 Metern, jedoch mit deutlich erhöhtem Sturzrisiko bei Richtungswechseln oder Bodenunebenheiten. Aus neurologischer Sicht ist die vorhandene Restgehfähigkeit für eine sichere Alltagsmobilität im Außenbereich nicht ausreichend.

5. Fachärztliche Empfehlung

Aus neurologischer Sicht wird eine Versorgung mit einem sturzsicheren, selbstständig zu bedienenden Mobilitätshilfsmittel für den Nahbereich empfohlen. Ein Elektrorollstuhl mit Kippschutz und gedrosselter Geschwindigkeit erscheint geeignet, sofern ein Fahrtraining die kognitive und motorische Eignung bestätigt.

Ergotherapeutischer Bericht

Ergotherapie Nordwest

Praxis für Ergotherapie, Melanie Bruns

Nadorster Straße 60, 26123 Oldenburg

1. Behandlungsauftrag

Ergotherapeutische Befunderhebung im Auftrag des Hausarztes zur Beurteilung der Alltagskompetenz und Handlungsfähigkeit von Herrn Heinz Körner, Behandlung vom 20.05.2026 bis 03.06.2026, insgesamt vier Termine.

2. Befunderhebung Alltagsaktivitäten

Transfer Bett zu Rollstuhl gelingt mit Anleitung und Haltegriff, benötigt jedoch mehr Zeit als altersüblich. Greiffunktion beider Hände eingeschränkt durch verminderte Sensibilität, feinmotorische Aufgaben wie das Bedienen eines Schlüssels gelingen verlangsamt.

3. Beobachtung im hauslichen Umfeld

Beim Hausbesuch am 27.05.2026 zeigte sich, dass Herr Körner die Wohnungstür nur mit Mühe selbstständig öffnen kann, wenn er sich gleichzeitig am Rollator festhalten muss. Die Küchenarbeitsfläche ist im Stehen nur kurzzeitig nutzbar.

4. Einschätzung zur Hilfsmittelnutzung

Ein Elektrorollstuhl würde die Hände für Greif- und Bedienaufgaben freihalten, während Gehstock und Rollator beide Hände zur Stabilisierung binden. Dies ist für die Verrichtung alltäglicher Handlungen wie Türöffnen, Briefkasten leeren oder Einkaufstasche tragen von Bedeutung.

5. Empfehlung

Aus ergotherapeutischer Sicht wird die Versorgung mit einem Elektrorollstuhl befürwortet, verbunden mit einem strukturierten Bedienungstraining über vier bis sechs Einheiten.

Physiotherapeutischer Bericht

Physiotherapie Am Stadtwall

Praxis Timo Elsholz

Stau 15, 26122 Oldenburg

1. Behandlungsverlauf

Physiotherapeutische Behandlung seit Januar 2026, zweimal wöchentlich, Schwerpunkt Gangschulung, Gleichgewichtstraining und Kräftigung der Beinmuskulatur nach Hüft-TEP links.

2. Aktueller Trainingsstand

Trotz regelmäßiger Übungsbehandlung konnte die Gehstrecke in den letzten sechs Monaten nicht wesentlich gesteigert werden. Die Standsicherheit bleibt durch die diabetische Polyneuropathie limitiert, das Sturzrisiko wird durch Übungen nur bedingt reduziert.

3. Sturzereignisse im Behandlungszeitraum

Nach Angaben des Patienten kam es im Behandlungszeitraum zu drei Stürzen, davon zwei im Wohnungsflur und einer auf dem Gehweg vor dem Haus, jeweils ohne schwere Verletzungsfolgen, jedoch mit zunehmender Sturzanst.

4. Physiotherapeutische Einschätzung

Eine weitere Verbesserung der Gehfähigkeit über das aktuelle Niveau hinaus ist nach fachlicher Einschätzung nur eingeschränkt zu erwarten, da die zugrunde liegende Polyneuropathie nicht reversibel ist. Die Fortführung der Physiotherapie dient dem Erhalt der Restmobilität, ersetzt aber keine geeignete Hilfsmittelversorgung für den Nahbereich außerhalb der Wohnung.

Wohnungs-Rundgang-Protokoll mit Skizzenbeschreibung

RehaTechnik Albrecht GmbH

Fachhandel für Rehabilitationstechnik

Cloppenburger Straße 302, 26133 Oldenburg

1. Termin und Anwesende

Hausbesuch am 19.05.2026 durch den RehaTechniker Jonas Wiechmann. Anwesend waren Herr Körner und seine Tochter Frau Dagmar Lindqvist.

2. Raumbeschreibung mit Maßangaben

Bereich	Masse und Beschaffenheit	Bewertung für Elektrorollstuhl
Hauseingang	Zwei Stufen a 16 cm, kein Handlauf	Rampe oder Treppenlift erforderlich, gesondert zu prüfen
Treppenhaus zur Wohnung im ersten Obergeschoss	Breite 110 cm, kein Aufzug	Elektrorollstuhl bleibt im Erdgeschoss, Transferlösung nötig
Wohnungsflur	Breite 95 cm, ein Wandvorsprung	ausreichend für kompakten Elektrorollstuhl
Wohnzimmer	18 Quadratmeter, ein Teppich mit erhöhter Kante	Teppichkante zu entfernen oder abzuflachen
Küche	schmal, Arbeitsfläche 60 cm Durchgangsbreite	eingeschränkt befahrbar, Rangieren erschwert
Badezimmer	Türbreite 70 cm, keine Schwellenfreiheit	nicht mit Elektrorollstuhl befahrbar, Rollator im Bad erforderlich

3. Skizzenbeschreibung

Die beigegefügte Handskizze (siehe jpg/wohnungsskizze_koerner.jpg) zeigt den Grundriss der Wohnung mit eingezeichneten Wegstrecken vom Hauseingang über das Treppenhaus zur Wohnungstür sowie die Innenwege zwischen Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer und Bad. Die kritischen Engstellen bei Küche und Bad sind rot markiert, die für den Elektrorollstuhl geeigneten Bereiche grün.

4. Außenbereich

Der Gehweg vor dem Haus ist asphaltiert, weist jedoch nach 40 Metern eine abgesenkte, aber leicht schräge Bordsteinkante zur Querungshilfe auf. Die nächste Apotheke liegt in etwa 180 Metern Entfernung, der Hausarzt in etwa 600 Metern.

5. Fazit des RehaTechnikers

Für den Innenbereich der Wohnung sowie den unmittelbaren Nahbereich nach Überwindung der Eingangsstufen ist ein kompakter Elektrorollstuhl technisch geeignet. Die beiden Eingangsstufen erfordern zusätzlich eine mobile Rampe oder einen baulichen Umbau, der gesondert bei der Pflegekasse zu beantragen wäre.

Kostenvoranschlag mit Alternativen, vollständige Fassung

RehaTechnik Albrecht GmbH

Fachhandel für Rehabilitationstechnik

Cloppenburger Straße 302, 26133 Oldenburg

Kostenvoranschlag Nr. RTA-2026-3381 vom 20.05.2026

1. Hauptangebot: Kompakter Elektrorollstuhl

Position	Bezeichnung	Einzelpreis EUR
1	Elektrorollstuhl Innenraum- und Nahbereichsklasse B	8990.00
2	Kippschutz hinten	310.00
3	Zusatzakku für erweiterte Reichweite	540.00
4	Fahrtraining, sechs Einheiten	480.00
5	Anpassung Sitzsystem	670.00

Gesamtsumme Hauptangebot: 10990.00 EUR

2. Alternative 1: Aufsatz-Antrieb für vorhandenen Faltrollstuhl

Ein elektrischer Zusatzantrieb, der auf den bereits vorhandenen manuellen Faltrollstuhl aufgesetzt wird, käme auf etwa 4200.00 EUR. Diese Lösung würde die Anschaffung eines komplett neuen Rollstuhls vermeiden, ist jedoch technisch nur eingeschränkt für die schmalen Innenräume der Wohnung geeignet, da sich die Gesamtbreite des Systems um zusätzliche 12 Zentimeter vergrößert.

3. Alternative 2: Standard-Elektrorollstuhl ohne Sonderausstattung

Ein einfacheres Modell ohne Zusatzakku und ohne individuelle Sitzanpassung würde etwa 6100.00 EUR kosten, würde nach fachlicher Einschätzung des Sanitätshauses jedoch die notwendige Reichweite für den täglichen Weg zur Apotheke und zum Hausarzt nicht zuverlässig gewährleisten.

4. Vergleich mit dem von der Kasse favorisierten Standard-Faltrollstuhl

Ein Standard-Faltrollstuhl aus dem Vertragssortiment der Krankenkasse liegt bei etwa 740.00 EUR, setzt aber durchgehend eine schiebende Begleitperson voraus und stellt keine selbstständige Mobilität her.

5. Empfehlung des Sanitätshauses

Aus fachlicher Sicht wird das Hauptangebot empfohlen, da es die einzige Option ist, die sowohl den räumlichen Anforderungen der Wohnung als auch der erforderlichen Reichweite für den Nahbereich gerecht wird.

Vergleichsangebot der Krankenkasse, Standardmodell

Weser-Ems Gesundheitskasse

Leistungsabteilung Hilfsmittel

Huntestraße 14, 26135 Oldenburg

Schreiben vom 09.06.2026 an das Sanitätshaus RehaTechnik Albrecht GmbH, zur Kenntnis an den Versicherten.

1. Angebot der Kasse

Die Weser-Ems Gesundheitskasse bietet im Rahmen ihres Vertragssortiments einen Standard-Faltrollstuhl zum Vertragspreis von 740.00 EUR sowie ergänzend eine Unterarmgehstütze zum Preis von 38.00 EUR an. Beide Hilfsmittel seien im Hilfsmittelverzeichnis unter Produktgruppe 18 und 22 gelistet und aus Sicht der Kasse ausreichend.

2. Begründung der Kasse

Nach der Stellungnahme des Medizinischen Dienstes vom 05.06.2026 bestehe eine Restgehfähigkeit, die in Verbindung mit einem Rollator und einem Faltrollstuhl für Begleitwege ausreiche. Die Kasse verweist auf das Wirtschaftlichkeitsgebot nach Paragraph 12 SGB V.

3. Reaktion der Kanzlei

Mit Schreiben vom 16.06.2026 weist die Kanzlei darauf hin, dass der Faltrollstuhl nach dem privaten Reha-Gutachten vom Versicherten nicht selbstständig angetrieben werden kann und daher keine gleich geeignete Alternative darstellt. Das Vergleichsangebot wird ausdrücklich nicht angenommen.

Antrag auf Einholung eines Zweitgutachtens

Kanzlei Ahlers und Brinkmann, Fachanwälte für Sozialrecht, Oldenburg

Bearbeiter: Rechtsanwalt Joost Ahlers

Staulinie 8, 26122 Oldenburg

Telefon 0441 77 03 30, Telefax 0441 77 03 39

USt-IdNr. DE 812 447 903

An die Weser-Ems Gesundheitskasse, Leistungsabteilung Hilfsmittel, Schreiben vom 22.06.2026.

1. Antrag

Namens des Herrn Heinz Körner wird beantragt, vor abschließender Entscheidung über den Widerspruch ein unabhängiges Zweitgutachten einzuholen, das auf einer persönlichen Untersuchung und einer praktischen Erprobung des beantragten Elektrorollstuhls im Wohnumfeld beruht.

2. Begründung

Die bisherige Stellungnahme des Medizinischen Dienstes beruht ausschließlich auf Aktenlage, ohne eigene körperliche Untersuchung, Gehprobe oder Erprobung der in Betracht kommenden Hilfsmittel. Demgegenüber stützt sich das private Gutachten von RehaTechnik Albrecht auf eine mehrstündige praktische Erprobung im tatsächlichen Wohnumfeld. Angesichts dieser Diskrepanz erscheint eine erneute, unabhängige Begutachtung sachgerecht.

Es wird angeregt, mit der Begutachtung eine Fachärztin oder einen Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin zu beauftragen, die oder der weder für die Krankenkasse noch für den Kläger bereits tätig geworden ist.

Widerspruchsbescheid

Weser-Ems Gesundheitskasse

Krankenversicherung und Pflegeversicherung

Leistungsabteilung Hilfsmittel

Huntestraße 42, 26135 Oldenburg

Telefon 0441 55 219-0, Telefax 0441 55 219-90

Aktenzeichen: WEK-HM-2026-4471

Oldenburg, den 24.06.2026

In der Verwaltungssache

Herr Heinz Körner, geboren am 03.02.1948, wohnhaft Peterstraße 18, 26122 Oldenburg,

gegen den Bescheid vom 10.06.2026 über die Ablehnung der Versorgung mit einem Elektrorollstuhl,

Tenor

Der Widerspruch vom 20.06.2026 gegen den Bescheid vom 10.06.2026 wird zurückgewiesen.

Sachverhalt

Der Widerspruchsführer beantragte am 12.05.2026 die Versorgung mit einem Elektrorollstuhl mit Nahbereichs- und Innenraumtauglichkeit. Grundlage war die ärztliche Verordnung von Dr. Stahlmann vom 07.05.2026 sowie der Facharztbericht von Dr. Radtke vom 17.05.2026. Der Medizinische Dienst nahm am 05.06.2026 Stellung und hielt eine Versorgung mit Unterarmgehstütze, vorhandenem Rollator und Standard-Faltrollstuhl für ausreichend. Mit Bescheid vom 10.06.2026 lehnte die Krankenkasse den Antrag ab. Hiergegen legte der Widerspruchsführer am 20.06.2026 form- und fristgerecht Widerspruch ein.

Gründe

Der Widerspruch ist zulässig, aber unbegründet.

Nach Paragraph 33 Absatz 1 SGB V haben Versicherte Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln, die im Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine Behinderung auszugleichen. Der Anspruch besteht nicht, wenn das Hilfsmittel als allgemeiner Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens anzusehen ist oder wenn es nach Paragraph 34 SGB V ausgeschlossen ist.

Die Krankenkasse ist an die Empfehlung des Medizinischen Dienstes vom 05.06.2026 gebunden, soweit diese schlüssig und nachvollziehbar ist. Danach verfügt der

Widerspruchsführer über eine Restgehfähigkeit, die mit den vorhandenen Hilfsmitteln Rollator und Unterarmgehstütze im häuslichen Umfeld ausreichend ausgeglichen werden kann. Der beantragte Elektrorollstuhl geht über den Basisausgleich hinaus, den die gesetzliche Krankenversicherung schuldet.

Das im Widerspruchsverfahren vorgelegte private Reha-Gutachten vom 18.06.2026 wurde geprüft. Es führt nach Auffassung der Kasse nicht zu einer anderen Bewertung, da es auf einer einmaligen Untersuchung im Wohnumfeld beruht und keine neuen medizinischen Befunde gegenüber der Aktenlage des Medizinischen Dienstes enthält.

Der Widerspruch war daher zurückzuweisen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Widerspruchsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim Sozialgericht Oldenburg, Klingenbergstraße 4, 26133 Oldenburg, erhoben werden.

Klageschrift

Kanzlei Ahlers und Brinkmann, Fachanwälte für Sozialrecht, Oldenburg

Bearbeiter: Rechtsanwalt Joost Ahlers

Staulinie 8, 26122 Oldenburg

Telefon 0441 77 03 30, Telefax 0441 77 03 39

USt-IdNr. DE 812 447 903

An das Sozialgericht Oldenburg, Klingenbergstraße 4, 26133 Oldenburg

Oldenburg, den 03.07.2026

In dem Rechtsstreit

des Herrn Heinz Körner, Peterstraße 18, 26122 Oldenburg, Kläger,

Prozessbevollmächtigte: Kanzlei Ahlers und Brinkmann, Staulinie 8, 26122 Oldenburg,

gegen

die Weser-Ems Gesundheitskasse, Huntestraße 42, 26135 Oldenburg, Beklagte,

wird namens und im Auftrag des Klägers Klage erhoben und beantragt:

Anträge

1. Der Bescheid der Beklagten vom 10.06.2026 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 24.06.2026 wird aufgehoben.
2. Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger mit einem geeigneten Elektrorollstuhl mit Innenraum- und Nahbereichstauglichkeit entsprechend der Verordnung vom 07.05.2026 zu versorgen.
3. Die Beklagte trägt die notwendigen außergerichtlichen Kosten des Klägers.

Begründung

1. Sachverhalt

Der 78-jährige Kläger leidet an einer Spinalkanalstenose, einer diabetischen Polyneuropathie sowie den Folgen einer Hüft-Totalendoprothese links. Er lebt allein im ersten Obergeschoss eines Altbaus in Oldenburg. Wegen Sturzgefahr, Sensibilitätsstörungen und rascher Erschöpfung ist ihm eine selbständige Fortbewegung im Nahbereich mit den bislang zur Verfügung gestellten Hilfsmitteln nicht möglich.

Die Beklagte lehnte die Versorgung mit Bescheid vom 10.06.2026 ab und wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 24.06.2026 zurück.

II. Rechtliche Würdigung

Der Kläger hat einen Anspruch aus Paragraph 33 Absatz 1 SGB V. Der Elektrorollstuhl ist zum Ausgleich der Behinderung im Bereich der Mobilität erforderlich. Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, unter anderem B 3 KR 3/19 R, ist bei der Prüfung des Basisausgleichs nicht allein auf die Fähigkeit zu wenigen Schritten im Wohnbereich abzustellen, sondern auf die Erschließung eines Bewegungsraums, der die Nutzung öffentlicher Wege, Ärzte und Geschäfte im Nahbereich der Wohnung ermöglicht.

Die von der Beklagten angeführten Alternativen sind nicht gleich geeignet. Ein Rollator setzt ausreichende Standsicherheit und Ausdauer voraus, die beim Kläger wegen der Polyneuropathie nicht durchgehend gegeben sind. Ein manueller Rollstuhl kann vom Kläger wegen der Schulterbeschwerden nicht dauerhaft selbständig angetrieben werden. Beide Alternativen stellen daher keinen vollwertigen Ersatz für den beantragten Elektrorollstuhl dar.

Das Wirtschaftlichkeitsgebot nach Paragraph 12 SGB V steht dem Anspruch nicht entgegen, da eine nicht geeignete, günstigere Versorgung keine wirtschaftliche Alternative im Sinne dieser Vorschrift darstellt.

III. Beweisantritte

Zum Beweis der Tatsache, dass der Kläger im Nahbereich nicht ausreichend sicher mobil ist, wird angeboten:

Einholung eines Sachverständigengutachtens zur Gehfähigkeit und Fahrsicherheit,

Zeugenvernehmung der Tochter des Klägers, Frau Dr. Maren Körner, zum Alltag und zu Sturzereignissen,

Beiziehung der Behandlungsunterlagen von Dr. Stahlmann und Dr. Radtke.

Klageerwiderung

Weser-Ems Gesundheitskasse

Krankenversicherung und Pflegeversicherung

Leistungsabteilung Hilfsmittel

Huntestraße 42, 26135 Oldenburg

Telefon 0441 55 219-0, Telefax 0441 55 219-90

An das Sozialgericht Oldenburg

Oldenburg, den 22.07.2026

In dem Rechtsstreit Körner gegen Weser-Ems Gesundheitskasse, Aktenzeichen S 12 KR 188/26,

wird beantragt:

Die Klage wird abgewiesen.

Begründung

Die Klage ist unbegründet. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Versorgung mit dem beantragten Elektrorollstuhl.

Der Medizinische Dienst hat in seiner Stellungnahme vom 05.06.2026 nachvollziehbar dargelegt, dass der Kläger über eine hinreichende Restgehfähigkeit verfügt, um sich mit Unterarmgehstütze und Rollator im häuslichen Umfeld und auf kurzen ebenen Wegen zu bewegen. Für längere Strecken steht dem Kläger ein Standard-Faltrollstuhl zur Verfügung, der mit Unterstützung der Tochter genutzt werden kann.

Die gesetzliche Krankenversicherung schuldet nach ständiger Rechtsprechung nur den Basisausgleich der Behinderung, nicht die Herstellung größtmöglicher Mobilität. Die Beklagte verweist hierzu auf die Entscheidung des Bundessozialgerichts B 3 KR 4/16 R, wonach der Ausgleich sich am Basisbedürfnis orientiert und nicht an einer vollständigen Gleichstellung mit der Mobilität eines Nichtbehinderten.

Die Wohnsituation des Klägers, insbesondere die fehlende Barrierefreiheit des Altbaus und die Lage im ersten Obergeschoss, begründet für sich genommen keinen Anspruch gegen die Krankenversicherung. Bauliche Hindernisse und die fehlende ständige Verfügbarkeit einer Begleitperson fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich der gesetzlichen Krankenversicherung.

Die von Klägerseite angeführte Entscheidung B 3 KR 3/19 R ist nach Auffassung der Beklagten nicht auf den vorliegenden Fall übertragbar, da dort eine vollständige Rollstuhlpflichtigkeit ohne jede Restgehfähigkeit vorlag. Im vorliegenden Fall besteht

demgegenüber eine relevante Restgehfähigkeit, die vom Kläger nicht hinreichend widerlegt wurde.

Die Beklagte regt an, ein Gutachten zur tatsächlichen Gehfähigkeit und zur Eignung der vorhandenen Hilfsmittel einzuholen, bevor über die Notwendigkeit der begehrten elektrischen Versorgung entschieden wird.

Beweisbeschluss

Sozialgericht Oldenburg

Kammer für Krankenversicherungssachen

Klingenbergstraße 4, 26133 Oldenburg

Aktenzeichen: S 12 KR 188/26

Oldenburg, den 05.08.2026

In dem Rechtsstreit Körner gegen Weser-Ems Gesundheitskasse beschließt die Kammer:

Beschluss

1. Es wird gemäß Paragraf 106 SGG Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens.
2. Zum Sachverständigen wird bestimmt: Prof. Dr. med. Anneliese Wickenrath, Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie, Physikalische und Rehabilitative Medizin, Bremen.

Beweisfragen

1. Welche Wegstrecke kann der Kläger nach dem gegenwärtigen Gesundheitszustand mit einem Rollator sicher und ohne relevantes Sturzrisiko zurücklegen?
2. Ist der Kläger in der Lage, einen manuellen Aktivrollstuhl über einen Nahbereich von mindestens 500 Metern selbständig anzutreiben, insbesondere unter Berücksichtigung der Schulterbeschwerden?
3. Besteht bei Nutzung eines Standard-Faltrollstuhls ohne Begleitperson eine ausreichende Sicherheit gegen Sturz und Unterzuckerungsfolgen?
4. Ist der Kläger unter Berücksichtigung von Sehvermögen, Reaktionsvermögen und Sensibilitätsstörungen in der Lage, einen Elektrorollstuhl mit gedrosselter Geschwindigkeit sicher zu führen?
5. Welche Auswirkungen hat die jeweilige Versorgung auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Sinne des Basisausgleichs?

Hinweis an die Beteiligten

Den Beteiligten wird Gelegenheit gegeben, innerhalb von zwei Wochen ergänzende Fragen an den Sachverständigen zu stellen. Der Sachverständigen wird die vollständige Verwaltungsakte einschließlich der Stellungnahme des Medizinischen Dienstes und des privaten Reha-Gutachtens übersandt.

Gerichtliches Sachverständigengutachten

Prof. Dr. med. Anneliese Wickenrath

Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie, Physikalische und Rehabilitative Medizin

Domsheide 9, 28195 Bremen

Auftraggeber: Sozialgericht Oldenburg, Aktenzeichen S 12 KR 188/26

Untersuchungstermin: 02.09.2026, Bremen

Gutachten vom 16.09.2026

1. Auftrag

Mit Beweisbeschluss vom 05.08.2026 wurde die Unterzeichnende beauftragt, zur Gehfähigkeit, zur Nutzbarkeit eines manuellen Rollstuhls sowie zur Fahrsicherheit mit einem Elektrorollstuhl bei Herrn Heinz Körner Stellung zu nehmen.

2. Untersuchungsbefund

Der Kläger erschien in Begleitung seiner Tochter zur Untersuchung. Klinisch zeigt sich eine deutliche Gangunsicherheit mit verkürzter Schrittlänge und breitbasigem Gangbild. Bei der Gehprobe im Klinikflur legte der Kläger mit Rollator eine Strecke von etwa 40 Metern zurück, danach musste er sich wegen Erschöpfung und einsetzendem Schwindel setzen. Eine Sensibilitätsprüfung der Füße ergab eine deutlich herabgesetzte Berührungsempfindung beidseits, vereinbar mit der bekannten diabetischen Polyneuropathie.

Die Schulterbeweglichkeit rechts ist endgradig eingeschränkt, links besteht Zustand nach der Hüft-TEP ohne relevante Einschränkung der oberen Extremität. Beim Antriebsversuch mit einem testweise bereitgestellten manuellen Aktivrollstuhl konnte der Kläger eine Strecke von 30 Metern auf ebenem Boden zurücklegen, danach zeigte sich eine deutliche muskuläre Erschöpfung der Schultern.

Der Fahrversuch mit einem auf niedrige Geschwindigkeit programmierten Elektrorollstuhl verlief unauffällig. Der Kläger zeigte ein sicheres Bedienverhalten, angemessene Reaktionszeiten und keine Anzeichen von Fehlbedienung in mehreren Kurvenfahrten und beim Anhalten vor Hindernissen.

3. Beantwortung der Beweisfragen

Beweisfrage	Untersuchungsergebnis
Wegstrecke mit Rollator	etwa 40 Meter, danach Erschöpfung und Schwindel
Manueller Rollstuhl Nahbereich	nach etwa 30 Metern deutliche Erschöpfung der Schultermuskulatur
Sicherheit Standard-Faltrollstuhl ohne Begleitung	nicht ausreichend wegen Sturz- und Unterzuckerungsrisiko bei fehlender Aufsicht
Fahrsicherheit Elektrorollstuhl gedrosselt	im Fahrversuch unauffällig, sicheres Bedienverhalten
Teilhabe-Auswirkung	Elektrorollstuhl würde selbständige Wege im

	Nahbereich ermöglichen, die derzeit nicht zurückgelegt werden können
--	--

4. Zusammenfassende Beurteilung

Die vorhandenen Hilfsmittel Rollator und Standard-Faltrollstuhl ermöglichen dem Kläger nach den erhobenen Befunden keine sichere und ausdauernde Fortbewegung im Nahbereich der Wohnung. Die im Fahrversuch festgestellte sichere Bedienung eines gedrosselten Elektrorollstuhls spricht aus gutachterlicher Sicht für die grundsätzliche Eignung dieses Hilfsmittels.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

technisches_datenblatt_elektrorollstuhl.pdf

pdfs/technisches_datenblatt_elektrorollstuhl.pdf

Technisches Datenblatt

Elektrorollstuhl Compacta N6 - Innen- und Nahbereich

Dokumentnummer	RT-ER-26-0519	Ausgabedatum	20. Mai 2026
Bezug	Kostenvoranschlag KA-2026-1178	Versicherter	Dr. Walter Körner

1. Technische Ausführung

Merkmal	Ausführung Compacta N6
Abmessungen	Gesamtbreite 58 cm; Gesamtlänge 104 cm; Höhe der Rückenlehne 53 cm
Wendekreis	95 cm; erforderliche lichte Türbreite mindestens 80 cm
Fahrleistung	Höchstgeschwindigkeit 6 km/h; Reichweite bis 25 km je Akkuladung
Antrieb und Batterie	Zwei 320-Watt-Motoren; zwei AGM-Batterien mit je 50 Ah; Ladegerät 8 A
Zuladung	Nutzergewicht bis 130 kg; Eigengewicht einschließlich Batterien 78 kg
Sitzsystem	Sitzbreite 46 cm; Sitztiefe 46 cm; Sitzhöhe von 45 bis 51 cm einstellbar
Rücken und Armlehnen	Rückenwinkel von 90 bis 120 Grad; hochschwenkbare, höhenverstellbare Armlehnen
Steuerung	Programmierbarer Joystick rechts; Bedienkraft und Beschleunigung individuell einstellbar
Sicherheit	Kippschutz, elektromagnetische Bremse, Beckengurt, Beleuchtung und Signalhorn
Transport	Sitz- und Antriebseinheit trennbar; schwerstes Einzelteil 42 kg; Verzurrpunkte gekennzeichnet

2. Vorgesehene Lieferkonfiguration

Für Herrn Dr. Körner ist die Joysticksteuerung rechts vorgesehen. Geliefert werden ferner ein abnehmbarer Beckengurt, winkelvestellbare Fußplatten, Kippschutzrollen, Stockhalter, Gelbatterie-Ladegerät und eine wetterfeste Abdeckhaube. Vor Übergabe werden Sitzhöhe, Armlehnen, Beschleunigung und Bremsverhalten in der Wohnung eingestellt.

3. Einsatzbereich und Grenzen

Das Modell ist für Innenräume sowie befestigte Wege im unmittelbaren Wohnumfeld bestimmt. Es bewältigt abgesenkte Bordsteine bis 5 cm und Steigungen bis 8 Prozent. Es ist nicht für Treppen, unbefestigte Waldwege, längere Überlandfahrten oder die Nutzung ohne vorherige Einweisung vorgesehen. Die Eignung im konkreten Wohnumfeld ist durch eine Probefahrt zu prüfen.

4. Übergabe, Einweisung und Service

Die Übergabe umfasst eine mindestens 60-minütige Einweisung, Brems- und Wendemanöver im Hausflur, das sichere Laden der Batterien sowie eine Probefahrt zum Briefkasten und zur nächsten abgesenkten Straßenquerung. Der mobile Kundendienst ist werktags von 08:00 bis 17:00 Uhr unter 0441 887720 erreichbar. Ersatzteile werden für mindestens acht Jahre vorgehalten.